FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

TEST CONDUCTUAL DE MEMORIA DE RIVERMEAD (RBMT)

Eje V: Neurocognición • Evaluación Ecológica de la Memoria en la Vida Diaria (Wilson et al.; Alonso & Prieto, 2004)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Test Conductual de Memoria de Rivermead (RBMT; Versión Estándar y Baremos > 70 años).
Nombre Original	Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT; Wilson, Cockburn & Baddeley, 1985, 1989).
Autores Originales	Barbara A. Wilson, Janet Cockburn y Alan D. Baddeley (Medical Research Council, UK).
Baremación España / Mayores	Mª Ángeles Alonso y Pedro Prieto (2004, Universidad de La Laguna; Psicothema).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Memoria ecológica cotidiana, prospectiva, episódica y topográfica.
Tipo de Instrumento	Batería neuropsicológica de ejecución ecológica y simulación conductual directa.
Composición de Tareas	12 subpruebas cotidianas valoradas en Puntuación Funcional (0-12) y Perfil Estándar (0-24).
Población y Rango	Adultos (16-69 años) y ancianos (70 a 97 años); daño cerebral adquirido, ACV y demencias.
Tiempo de Administración	25 a 35 minutos de administración interactiva.
Régimen de Licencia	Material comercial original (Pearson Clinical / Nivel C). Baremos españoles de dominio abierto.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: VALIDEZ ECOLÓGICA VS. TESTS DE LABORATORIO

El **RBMT** fue diseñado para superar la brecha entre los tests psicométricos clásicos de laboratorio y el funcionamiento funcional real:

1. **Limitación de los Tests Clásicos:** Pruebas como los pares asociados de Wechsler exploran la memoria abstracta en condiciones artificiales, permitiendo que sujetos amnésicos con alta reserva cognitiva compensen y obtengan puntuaciones engañosamente normales.
2. **Simulación de Situaciones Cotidianas:** El RBMT reproduce con exactitud las situaciones donde suelen fracasar los pacientes con quejas mnésicas: olvidar dónde dejaron un objeto personal, no recordar el nombre de un conocido, saltarse una cita acordada o perderse en un recorrido físico nuevo.
3. **Evaluación de la Memoria Prospectiva:** Es una de las pruebas pioneras en evaluar formalmente la memoria de intenciones futuras condicionada al tiempo o a claves ambientales (recordar preguntar por una cita cuando suene un timbre o entregar un mensaje).

3. ESTRUCTURA DE LAS 12 SUBPRUEBAS CONDUCTUALES DEL RBMT

Subprueba	Puntuación	Proceso Mnésico y Procedimiento Ecológico
1. Recuerdo de Nombre	0 - 2 pts	Asociación cara-nombre inmediato y tras intervalo demorado (fotografía de un rostro).
2. Objeto Escondido	0 - 2 pts	Recuerdo demorado de dónde se guardó un objeto personal del propio paciente.
3. Recuerdo de una Cita	0 - 2 pts	Memoria prospectiva temporal: preguntar al examinador por su cita al sonar una alarma a los 20 min.
4. Reconocimiento Dibujos	0 - 2 pts	Reconocimiento visual inmediato y diferido de 20 láminas de objetos cotidianos.
5-6. Historia Inm. y Dem.	0 - 4 pts	Memoria auditivo-verbal lógica: recuerdo de una historia leída (inmediato y demorado).
7. Reconocimiento Caras	0 - 2 pts	Reconocimiento visual de 5 fotografías de rostros entre 10 distractores no familiares.
8-9. Recorrido Inm. y Dem.	0 - 4 pts	Memoria visoespacial y topográfica: reproducción de un trayecto de 5 pasos dentro de la sala.
10. Entrega de Mensaje	0 - 2 pts	Memoria prospectiva ligada a la acción: dejar un recado escrito en una parada del recorrido.
11-12. Orientación y Fecha	0 - 4 pts	Orientación temporo-espacial autobiográfica (año, mes, día exacto, lugar físico y ciudad).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, FIABILIDAD Y RENDIMIENTO METROLÓGICO EN MAYORES (> 70 AÑOS)

El estudio de validación para la población anciana hispanohablante (Alonso & Prieto, 2004; $N = 111$ ancianos de 70 a 97 años) constató:

Propiedad Psicométrica	Coeficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.81	Elevada homogeneidad en ancianos; IC del 95%: [0.75 - 0.86].
Validez Concurrente Raven	r = 0.46 (p < 0.001)	Correlación significativa con la capacidad de razonamiento general (Factor g).
Amplitud de Dígitos (WAIS)	r = 0.32 (dir) / 0.40 (inv)	Asociación moderada con la memoria operativa y memoria de trabajo fonológica.
Inmunidad ante la Ansiedad	r = −0.02 (STAI; p > 0.05)	La prueba no se ve contaminada por niveles de ansiedad de estado o rasgo del sujeto.
Sensibilidad al Envejecimiento	r = −0.24 (p < 0.05 con edad)	Capacidad contrastada para detectar declive gradual fisiológico vs. patológico.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN: PUNTUACIÓN FUNCIONAL VS. PERFIL DE PUNTUACIONES

• **Puntuación Funcional (0 a 12 pts):** Criterio pasa/no pasa binario (1 = ejecución normal; 0 = fallo funcional en la actividad).
• **Perfil de Puntuaciones (0 a 24 pts):** Gradación cuantitativa por ítem (2 = normal, 1 = límite/ayuda parcial, 0 = fallo total):

$$\text{Perfil Total RBMT} = \sum_{k=1}^{12} \text{Ítem}_k \quad (\text{Rango escalar: } 0 \text{ a } 24 \text{ puntos})$$

• **Elección Metodológica:** En geriatría y demencias incipientes, el **Perfil de Puntuaciones (24 pts)** es el estándar recomendado al aportar mayor variabilidad y granularidad discriminante frente a sutiles deterioros.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Perfil RBMT	P. Funcional	Diagnóstico Mnésico Clínico (Wilson; Alonso & Prieto)
Memoria Normal	22 a 24 puntos	10 a 12 puntos	Capacidad funcional conservada; desenvolvimiento autónomo en la vida diaria.
Deterioro Leve / Límite	**17 a 21 puntos**	**7 a 9 puntos**	**Sospecha de Deterioro Cognitivo Leve (DCL)** fallos en citas y nombres.
Deterioro Moderado	**10 a 16 puntos**	**4 a 6 puntos**	**Afectación funcional evidente** riesgo de accidentes por olvidos de medicación.
Deterioro Severo	0 a 9 puntos	0 a 3 puntos	Colapso mnésico masivo; cuadro demencial avanzado (dependencia total).

PUNTO DE CORTE EN ANCIANOS (PERFIL RBMT <= 16 PUNTOS):
En mayores de 70 años, una puntuación en el perfil inferior a 17 puntos (especialmente con fracaso en el recuerdo de citas y la historia diferida) exige descartar de inmediato etiología neurodegenerativa (Enfermedad de Alzheimer en fase inicial o demencia vascular).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN REHABILITACIÓN Y GERIATRÍA

PROTOCOLO DE VALORACIÓN ECOLÓGICA CON EL RBMT:

• **Paso 1 (Administración en Contexto de Queja):** Aplicar el RBMT ante adultos mayores con olvidos recurrentes en el hogar o pacientes tras ACV o traumatismo craneoencefálico.

• **Paso 2 (Análisis Cualitativo del Perfil):**

- *Fallo selectivo en citas y recados con memoria inmediata conservada:* Compromiso de la memoria prospectiva y control prefrontal; programar ayudas externas (alarmas, diarios).
- *Fallo tanto en recuerdo inmediato como demorado con colapso en reconocimiento:* Síndrome amnésico hipocámpico / cortical típico; sospecha fundada de Enfermedad de Alzheimer.
- *Perfil 17 a 21 puntos:* Evaluar reserva cognitiva con Raven o test de vocabulario para determinar si el rendimiento es menor al esperado para su nivel basal.

• **Paso 3 (Prescripción Terapéutica):** Diseñar el plan de estimulación cognitiva centrado en las tareas conductuales concretas falladas en el RBMT.

8. CASO ILUSTRATIVO: DIAGNÓSTICO PRECOZ DE DETERIORO MNÉSICO ECOLÓGICO

Identificación: Varón de 74 años, profesor jubilado, acude a consulta acompañado por su cónyuge, quien relata olvidos reiterados de citas médicas, pérdidas constantes de llaves y quemado de alimentos en la cocina. En el MMSE obtuvo 27/30 (“rendimiento normal”).
Evaluación Neuropsicológica con el RBMT:
• Puntuación Funcional = 6 / 12 (Deterioro moderado).
• **Perfil Total de Puntuaciones = 12 / 24 puntos** (Deterioro mnésico evidente, percentil < 15 según baremo de Alonso & Prieto).
• *Desglose de Subpruebas:* Fallo total (0 pts) en recuerdo de cita diferida, objeto escondido y recuerdo diferido de la historia. Recuerdo de nombres = 1 pt. Reconocimiento de dibujos y caras = 2 pts (conservado). Orientación = 2 pts; Fecha = 1 pt.
Integración Diagnóstica: A pesar de puntuar normal en pruebas de cribado global, el RBMT destapó un fallo grave en la memoria episódica diferida y prospectiva cotidiana.
Intervención: Se diagnosticó Deterioro Cognitivo Leve amnésico de multidominio. Se implementaron adaptaciones ambientales de seguridad en el hogar y entrenamiento en el uso de agenda electrónica supervisada.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD, DEONTOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EFECTO DE LA ESCOLARIDAD:
En analfabetos o baja escolaridad (< 4 años), los baremos bajan 2 a 3 puntos en el perfil sin que constituya demencia; ajustar con tabla Alonso.

SEGURIDAD VITAL DOMÉSTICA:
Puntuaciones inferiores a 10 puntos exigen supervisión activa de la toma de psicofármacos y del manejo de gas/llaves en el domicilio.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Alonso, M. A., & Prieto, P. (2004). Validación de la versión en español del Test Conductual de Memoria de Rivermead (RBMT) para población mayor de 70 años. *Psicothema*, 16(2), 325-328.
2. Wilson, B. A., Cockburn, J., & Baddeley, A. D. (1985). *The Rivermead Behavioural Memory Test*. Thames Valley Test Company (Bury St. Edmunds).
3. Wilson, B. A., Cockburn, J., Baddeley, A. D., & Hiorns, R. (1989). The development and validation of a test of everyday memory. *Neuropsychology*, 3(4), 227-237.
4. Mozaz Garde, M. J. (1991). *Test Conductual de Memoria de Rivermead (RBMT): Manual de instrucciones y adaptación española*. Thames Valley Test Company.